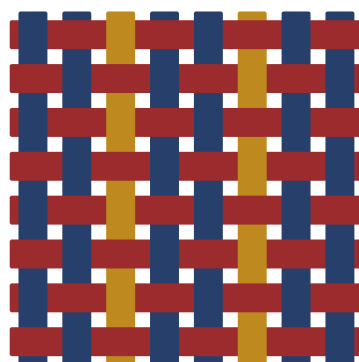




实验诊断 **A1+A2** 选择题冲刺包

NovaForge 视觉重排版 • 内容保持不变

Codex

2026-06-29

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

CONTENTS

1	实验诊断 A1+A2 选择题冲刺包	3
1.1	Part 0: 考研老师资料提取的 A2 题眼	3
1.1.1	0.1 呼吸系统病例题眼	3
1.1.2	0.2 血气、肺栓塞、ARDS、呼吸衰竭	3
1.1.3	0.3 胸腔积液三分法	4
1.1.4	0.4 心衰和心梗题眼	4
1.1.5	0.5 消化、肝胆、肾脏高频题眼	4
1.2	Part 1: A2 病例题识别卡	5
1.2.1	1. 血气酸碱	5
1.2.2	2. DIC/原发性纤溶	5
1.2.3	3. 贫血/溶血	5
1.2.4	4. 肝功能/黄疸	5
1.2.5	5. 肾功能/尿液检查	5
1.2.6	6. 脑脊液	5
1.2.7	7. 浆膜腔积液	6
1.2.8	8. 乙肝两对半	6
1.2.9	9. 甲状腺功能	6
1.2.10	10. 感染/炎症指标	6
1.2.11	11. 心肌标志物	6
1.2.12	12. 肿瘤标志物	6
1.3	Part 2: 检验组合判断表	6
1.4	Part 3: A1 高频秒杀点	7
1.4.1	血液学	7
1.4.2	凝血与止血	8
1.4.3	尿液/肾功能	8
1.4.4	肝功能/黄疸	8
1.4.5	生化/电解质/血糖	8
1.4.6	心肌标志物	8
1.4.7	免疫/肿瘤标志物	9
1.4.8	病原体/感染指标	9
1.5	Part 4: A2 高频陷阱 40 条	9
1.6	最后 15 分钟背诵页	10
1.7	Part 5: 加厚版系统速记	10
1.7.1	5.1 血液一般检查	10

1.7.2	5.2 贫血四大类型	11
1.7.3	5.3 凝血与出血	11
1.7.4	5.4 尿液与肾功能	11
1.7.5	5.5 肝功能和黄疸	11
1.7.6	5.6 脑脊液鉴别	12
1.7.7	5.7 浆膜腔积液	12
1.7.8	5.8 乙肝两对半	12
1.7.9	5.9 甲状腺功能	12
1.7.10	5.10 心肌标志物	13
1.8	Part 6: A2 自测清单	13

■ 1 实验诊断 A1+A2 选择题冲刺包

来源：实验诊断题库、知识点整理、课本/Codex 章节整理、考研老师整理资料。

说明：考研资料只提取老师整理的诊断公式、辅助检查、鉴别要点和病例题干模式；不采信 OCR 中的答案字母，不按考研原题押题。

1.1 Part 0: 考研老师资料提取的 A2 题眼

0.1 呼吸系统病例题眼

题干组合	快速判断	最关键检查/鉴别
慢性或反复咳嗽、咳痰 N 年 + 吸烟史 + 无咯血	COPD	肺功能；吸入支气管扩张剂后 FEV1/FVC <0.70 支持持续气流受限 HRCT 首选确诊
慢性咳嗽咳痰 N 年 + 大量脓痰/反复咯血 + 幼年百日咳或麻疹史	支气管扩张	
发作性咳嗽、喘息、胸闷 + 双肺哮鸣音	支气管哮喘	肺功能；重度/危重者先做动脉血气
青壮年 + 受凉后寒战高热 + 铁锈色痰 + 肺实变	肺炎链球菌肺炎	WBC/N $\uparrow$ ；胸片/CT 实变
老年/基础病 + 高热 + 红棕色胶冻样痰	克雷伯杆菌肺炎	胸片可有叶间隙下坠
年轻人 + 低热咽痛肌痛 + 体征轻影像重	支原体肺炎	病原学/血清学
旅行/接触史 + 肺炎 + 腹泻/意识改变	军团菌肺炎	尿抗原、血清抗体、培养
糖尿病/基础病 + 高热 + 脓血痰 + 多发空洞/液气囊腔	金葡菌肺炎	WBC 显著升高，影像多发空洞
意识障碍/酗酒/误吸 + 高热 + 大量臭脓痰	吸入性肺脓肿	胸片/CT 脓腔、液平
低热盗汗消瘦 + 咳嗽咯血 + 上肺病灶	肺结核	痰抗酸染色、培养；胸片常规首选

0.2 血气、肺栓塞、ARDS、呼吸衰竭

题干组合	快速判断	易错点
突发呼吸困难、胸痛 + 颈静脉充盈 + P2 亢进	急性肺栓塞	血气常 PaO $2\downarrow$ 、PaCO $2\downarrow$ 、pH $\uparrow$ ；确诊首选 CTPA
急性胰腺炎/严重感染/术后 + 呼吸困难 + 双肺浸润影	ARDS	血气 PaO $2\downarrow$ 、PaCO $2\downarrow$ 、pH $\uparrow$ ；看氧合指数
PaO 2 <60 mmHg, PaCO 2 不高	I 型呼吸衰竭	单纯低氧，不是 CO 2 潴留
PaO 2 <60 mmHg + PaCO 2 >50 mmHg	II 型呼吸衰竭	COPD 常见，氧疗不宜高浓度
COPD 患者嗜睡、意识模糊	肺性脑病/CO 2 潴留	首选动脉血气

0.3 胸腔积液三分法

题干组合	快速判断	关键陷阱
低热盗汗消瘦 + 胸水 ADA >45 U/L + 淋巴细胞为主	结核性胸腔积液	ADA 高不等于恶性
高热 + 胸水 WBC >10×10 ⁹ /L + 中性粒为主 + pH <7.30	脓胸	ADA 也可升高, 靠 WBC/pH/外观综合判断
中老年 + 无明显发热 + 血性胸水 + ADA <45 U/L + CEA 升高/细胞学阳性	恶性胸腔积液	确诊靠细胞学或胸膜活检
胸腔积液定位	影像首选胸片; 穿刺前定位用 B 超	明确性质靠胸腔穿刺和胸水检查

0.4 心衰和心梗题眼

题干组合	快速判断	最关键检查/鉴别
粉红色泡沫痰 不能平卧、夜间阵发性呼吸困难、双肺底湿啰音 + 心界扩大	急性左心衰 慢性左心衰	临床题眼很强 心脏超声常用
颈静脉怒张、肝大、肝颈静脉回流征阳性、下肢水肿	慢性右心衰	与肺心病、心包积液鉴别
持续剧烈胸痛 + 硝酸甘油无效 + 心肌坏死标志物↑ + ST 改变	急性心肌梗死	心电图首选; cTn 最特异、最有价值
心梗 vs 心绞痛	心梗疼痛更久、硝酸甘油效果差、心肌标志物升高	心绞痛标志物不升高
心梗 vs 肺栓塞	肺栓塞有右心负荷急增、低氧、P2 亢进	两者 D-二聚体都可升高, 不能单独鉴别

0.5 消化、肝胆、肾脏高频题眼

题干组合	快速判断	关键检查/鉴别
慢性乙肝/HBsAg 阳性或肝硬化 + 肝区痛 + 肝肿物 + AFP↑	原发性肝癌	AFP + B 超用于筛查; 确诊仍看影像/病理
呕血黑便 + 乙肝/肝硬化体征 + 脾大腹水	食管胃底静脉曲张破裂出血可能	胃镜明确
儿童/青少年 + 上感后 1-3 周 + 血尿水肿高血压 + C3↓/ASO↑	急性肾小球肾炎	Cr 多轻度升高
上感后 1-3 天即肉眼血尿 + 急性肾炎表现 + 少尿/无尿 + Cr 重度升高	IgA 肾病 急进性肾小球肾炎	与急性肾炎按出现时间鉴别 肾活检最有意义
间断水肿 >3 个月 + 蛋白尿/血尿/高血压 + 贫血 + Cr↑	慢性肾小球肾炎	与肾病综合征鉴别蛋白尿程度和血尿/高血压

1.2 Part 1: A2 病例题识别卡

1. 血气酸碱 【题干关键词】呼吸困难、COPD、肺炎/ARDS、休克、腹泻、呕吐、糖尿病酮症。

【关键检验组合】pH、PaCO₂、HCO₃⁻、PaO₂。

【最可能判断】先看 pH 定酸碱，再看 PaCO₂/HCO₃⁻ 定呼吸性或代谢性。

【常见问法】属于哪种酸碱失衡；是否低氧血症；是否呼吸衰竭。

【易错选项/陷阱】只看 pH 不看代偿；COPD 常见 CO₂ 潴留；肺栓塞/ARDS 可低氧伴 PaCO₂ 降低。

【一句话记忆】pH 定方向，PaCO₂ 看呼吸，HCO₃⁻ 看代谢。

2. DIC/原发性纤溶 【题干关键词】白血病、感染、休克、产科意外、广泛出血、瘀斑。

【关键检验组合】PLT↓ + PT/APTT 延长 + FIB↓ + FDP/D-D↑。

【最可能判断】DIC。

【常见问法】最符合哪种凝血障碍；下一步查什么；与原发性纤溶鉴别。

【易错选项/陷阱】DIC 是消耗性凝血障碍，不是单纯血小板减少；FIB 降低和 D-D/FDP 升高很关键。

【一句话记忆】血小板少、凝血慢、纤维蛋白原低、降解产物高 = DIC。

3. 贫血/溶血 【题干关键词】乏力苍白、心悸、黄疸、尿色深、月经过多、黑便。

【关键检验组合】Hb↓；MCV/MCH/MCHC；Ret；铁代谢；间接胆红素；Coombs。

【最可能判断】缺铁、巨幼、溶血、再障等。

【常见问法】贫血类型；最有价值检查；哪项支持溶血。

【易错选项/陷阱】缺铁不是只看 Hb，要看小细胞低色素和铁代谢；溶血看 Ret↑、间接胆红素↑、尿胆原↑。

【一句话记忆】缺铁小低铁低，溶血黄疸 Ret 高。

4. 肝功能/黄疸 【题干关键词】黄疸、尿色深、皮肤瘙痒、乏力纳差、右上腹痛、肝炎史。

【关键检验组合】TBIL/DBIL/IBIL、ALT/AST、ALP/GGT、尿胆红素、尿胆原。

【最可能判断】肝细胞性、梗阻性、溶血性黄疸。

【常见问法】黄疸类型；最支持哪项诊断；下一步检查。

【易错选项/陷阱】梗阻性黄疸看 DBIL、ALP、GGT；溶血性黄疸尿胆红素阴性。

【一句话记忆】转氨酶看肝细胞，ALP/GGT 看胆汁淤积，尿胆红素看结合胆红素。

5. 肾功能/尿液检查 【题干关键词】水肿、少尿、血尿、蛋白尿、尿频尿急尿痛、腰痛、感染后。

【关键检验组合】尿蛋白、尿 RBC/WBC、管型、BUN、Cr、C₃、ASO。

【最可能判断】肾小球肾炎、尿路感染、肾功能损害。

【常见问法】病变部位；最支持哪种肾病；下一步检查。

【易错选项/陷阱】肾小球病变常有蛋白尿、血尿和管型；尿路感染看白细胞尿和尿培养。

【一句话记忆】蛋白尿管型偏肾小球，尿频尿痛白细胞偏尿路感染。

6. 脑脊液 【题干关键词】高热、头痛、喷射性呕吐、脑膜刺激征、意识障碍。

【关键检验组合】压力、外观、细胞数及分类、蛋白、糖、氯化物、病原学。

【最可能判断】化脓性、结核性、病毒性脑膜炎鉴别。

【常见问法】脑脊液改变符合哪种脑膜炎。

【易错选项/陷阱】化脑多中性粒细胞为主、糖明显降低；结脑常糖和氯化物降低、蛋白升高；病脑糖多正常。

【一句话记忆】化脑浑浊中性多，结脑糖氯低，病脑糖多正常。

- 7. 浆膜腔积液** 【题干关键词】胸痛、气促、胸水、腹水、低热盗汗、肿瘤、心衰。
【关键检验组合】蛋白、LDH、细胞数及分类、ADA、pH、糖、细胞学。
【最可能判断】漏出液/渗出液；结核性、化脓性、恶性积液。
【常见问法】积液性质；最可能病因。
【易错选项/陷阱】结核性胸水 ADA↑、淋巴细胞多；脓胸 WBC 高、中性粒多、pH 低；恶性胸水靠细胞学/活检。
【一句话记忆】ADA 高想结核，pH 低中性多想脓胸，血性细胞学阳性想恶性。
- 8. 乙肝两对半** 【题干关键词】肝炎史、黄疸、肝功能异常、筛查乙肝感染状态。
【关键检验组合】HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc。
【最可能判断】感染、恢复、免疫、复制活跃。
【常见问法】哪项提示感染；哪项提示保护性抗体；复制活跃看什么。
【易错选项/陷阱】抗-HBs 是保护性抗体；HBsAg 阳性提示现症感染；HBeAg 常提示复制活跃、传染性强。
【一句话记忆】表抗原是感染，表抗体是保护，e 抗原看复制。
- 9. 甲状腺功能** 【题干关键词】怕热多汗、心悸、消瘦、食欲增加、突眼、甲状腺肿大。
【关键检验组合】T3/T4/FT3/FT4↑ + TSH↓。
【最可能判断】甲状腺功能亢进。
【常见问法】最有价值检查；原发性甲亢指标变化。
【易错选项/陷阱】不要只看 T3/T4，TSH 很关键；原发性甲亢 TSH 被抑制。
【一句话记忆】甲亢是甲状腺激素高，TSH 低。
- 10. 感染/炎症指标** 【题干关键词】发热、咳嗽、腹泻、局部感染、脓性分泌物。
【关键检验组合】WBC↑、中性粒细胞↑、核左移、CRP/PCT、培养。
【最可能判断】细菌感染倾向。
【常见问法】哪项提示细菌感染；最能明确病原的检查。
【易错选项/陷阱】WBC 只是支持，病原诊断靠培养/涂片/抗原核酸等。
【一句话记忆】白细胞中性高支持细菌，明确病原靠培养。
- 11. 心肌标志物** 【题干关键词】持续胸痛、大汗、硝酸甘油无效、心电图异常。
【关键检验组合】肌红蛋白、cTn、CK-MB。
【最可能判断】急性心肌损伤/心肌梗死。
【常见问法】最早升高；最特异；判断再梗死。
【易错选项/陷阱】肌红蛋白早但特异性差；肌钙蛋白特异性高；CK-MB 可辅助再梗死判断。
【一句话记忆】早看肌红，准看肌钙，回落再升看 CK-MB。
- 12. 肿瘤标志物** 【题干关键词】肝占位、乙肝/肝硬化、消瘦、便血、腹部包块。
【关键检验组合】AFP、CEA、CA 系列等。
【最可能判断】辅助提示肿瘤，不能单独确诊。
【常见问法】哪项支持原发性肝癌；哪项常用于消化道肿瘤辅助。
【易错选项/陷阱】肿瘤标志物不能替代病理；AFP 升高结合乙肝/肝占位才更有意义。
【一句话记忆】AFP 想肝癌，CEA 想消化道；确诊仍靠影像和病理。

1.3 Part 2: 检验组合判断表

检验结果组合	最可能诊断/判断	易错点
pH↓ + HCO ₃ ⁻ ↓	代谢性酸中毒	还要看 PaCO ₂ 是否代偿
pH↓ + PaCO ₂ ↑	呼吸性酸中毒	COPD、呼吸衰竭常见

检验结果组合	最可能诊断/判断	易错点
pH↑ + PaCO ₂ ↓	呼吸性碱中毒	肺栓塞、早期低氧过度通气可见
PaO ₂ ↓ + PaCO ₂ ↑	II 型呼吸衰竭	不是单纯缺氧，还有 CO ₂ 潴留
PaO ₂ ↓ + PaCO ₂ 正常/低	I 型呼吸衰竭	常见于换气障碍
WBC↑ + N%↑	细菌感染倾向	明确病原仍靠培养
WBC↑ + 幼稚细胞	白血病可能	需骨髓检查确认
Hb↓ + MCV↓ + MCH↓ + 血清铁↓	缺铁性贫血	需找慢性失血原因
Hb↓ + MCV↑	巨幼细胞性贫血	查叶酸、Vit B12
Hb↓ + Ret↑ + IBIL↑ + 尿胆原↑	溶血性贫血	尿胆红素常阴性
Coombs 阳性 + 溶血表现	自身免疫性溶血	可继发于 SLE 等
全血细胞减少 + Ret↓	再生障碍性贫血	骨髓增生低下支持
PLT↓ + PT/APTT 延长 + FIB↓ + FDP/D-D↑	DIC	不是单纯血小板减少
PT 延长明显	外源性凝血途径异常	关注凝血因子和肝病
APTT 延长明显	内源性凝血途径异常	血友病常考
ALT/AST↑ 为主	肝细胞损伤	不等于一定是病毒性肝炎
DBIL↑ + ALP↑ + GGT↑	胆汁淤积/梗阻性黄疸	结合影像看胆管扩张
IBIL↑ + 尿胆红素阴性	溶血性黄疸倾向	尿胆原常升高
尿胆红素阳性	结合胆红素升高	溶血性黄疸一般不阳性
尿蛋白 + 血尿 + 管型	肾小球病变	管型提示肾实质受累
BUN↑ + Cr↑	肾功能受损	需结合尿量和病因
C3↓ + ASO↑ + 感染后血尿	急性肾小球肾炎	与 IgA 肾病发生时间鉴别
尿 WBC↑ + 尿培养阳性	尿路感染	肾盂肾炎常伴发热腰痛
CSF 糖↓ + 蛋白↑ + 中性粒细胞为主	化脓性脑膜炎	需病原学确认
CSF 糖↓ + 蛋白↓ + 淋巴细胞为主	结核性脑膜炎	与化脑、病脑鉴别
CSF 糖多正常 + 淋巴细胞为主	病毒性脑膜炎	资料不足时不要硬判病原
胸水 ADA↑ + 淋巴细胞为主	结核性胸水	ADA 不是肿瘤确诊指标
胸水 WBC 极高 + 中性粒为主 + pH↓	脓胸	与结核性胸水鉴别
血性胸水 + 细胞学阳性	恶性胸水	确认靠细胞学/活检
HBsAg 阳性	乙肝现症感染	不代表一定复制活跃
抗-HBs 阳性	保护性抗体	可见于疫苗后或恢复后
HBeAg 阳性	病毒复制活跃、传染性强	需结合 HBV DNA
T3/T4↑ + TSH↓	原发性甲亢	TSH 不要漏看
cTn↑	心肌损伤/心梗支持	需结合胸痛和心电图
肌红蛋白早期↑	心梗早期线索	特异性差
AFP↑ + 乙肝/肝硬化 + 肝占位	原发性肝癌支持	不能脱离影像和病理
便潜血阳性 + Hb↓	消化道慢性失血	需内镜找病因

1.4 Part 3: A1 高频秒杀点

血液学

- 成人贫血判断先看 Hb，再用 MCV/MCH/MCHC 分类。
- 小细胞低色素性贫血优先想到缺铁性贫血。
- 缺铁性贫血：血清铁、铁蛋白降低，总铁结合力常升高。
- 巨幼细胞性贫血：MCV 增大，查叶酸和 Vit B12。
- 溶血性贫血：Ret 升高、间接胆红素升高、尿胆原升高。
- 自身免疫性溶血最关键：Coombs 试验阳性。
- 再障：全血细胞减少，Ret 降低，骨髓增生低下。
- 白血病确诊主要靠骨髓检查。

凝血与止血

- PLT 异常多表现为皮肤黏膜出血。
- 凝血因子异常多表现为深部组织、关节或肌肉出血。
- PT 反映外源性凝血途径。
- APTT 反映内源性凝血途径。
- FIB 降低、FDP/D-D 升高是 DIC 重要线索。
- D-D 升高提示继发性纤溶增强，但不是单独确诊 DIC。

尿液/肾功能

- 尿蛋白、血尿、管型组合提示肾实质尤其肾小球受累。
- 肾功能常看 BUN、Cr、eGFR。
- 急性肾小球肾炎常有感染后水肿、血尿、蛋白尿、高血压。
- 链球菌感染后急性肾炎常见 ASO 升高、C3 降低。
- 尿路感染关键是尿 WBC、尿培养。
- 肉眼血尿不等于肾小球病，结石、肿瘤、外伤也可见。

肝功能/黄疸

- ALT/AST 主要反映肝细胞损伤。
- ALP/GGT 升高明显提示胆汁淤积或胆道梗阻。
- 直接胆红素升高明显常见于梗阻性或肝细胞性黄疸。
- 间接胆红素升高明显要想到溶血。
- 尿胆红素阳性提示结合胆红素进入尿液。
- 溶血性黄疸尿胆红素多阴性，尿胆原可升高。

生化/电解质/血糖

- 空腹血糖、OGTT、HbA1c 是糖代谢判断核心。
- HbA1c 反映近 2-3 个月平均血糖。
- 尿酮体阳性要警惕酮症酸中毒相关情况。
- 腹泻、呕吐、脱水题要想到电解质、血气、肾功能。
- 血气先看 pH，再看 PaCO₂ 和 HCO₃⁻。

心肌标志物

- 肌红蛋白升高早，但特异性差。
- 肌钙蛋白对心肌损伤特异性高。
- CK-MB 可辅助判断心肌损伤动态变化和再梗死。
- 心梗题不要只看标志物，要结合胸痛和心电图。

免疫/肿瘤标志物

- ANA 常用于 SLE 筛查。
- 抗 dsDNA 对 SLE 诊断和活动性判断有价值。
- 抗 Sm 特异性较高。
- 补体 C3/C4 降低可见于 SLE 活动或免疫复合物相关疾病。
- AFP 常用于原发性肝癌辅助判断。
- CEA 常用于消化道肿瘤辅助判断。
- 肿瘤标志物不能替代病理诊断。

病原体/感染指标

- 细菌感染常见 WBC 和中性粒细胞升高。
- 病毒感染常见淋巴细胞比例相对增高，但要结合临床。
- 明确病原靠涂片、培养、抗原、抗体或核酸检测。
- 培养后药敏用于指导抗菌药物选择。

1.5 Part 4: A2 高频陷阱 40 条

1. 只看 pH 判断酸碱 → 还要看 PaCO_2 和 HCO_3^- 。
2. PaO_2 低就判 II 型呼衰 → II 型还要 PaCO_2 升高。
3. COPD 呼吸困难只写缺氧 → 还要警惕 CO_2 潴留。
4. 肺栓塞血气可低氧低碳酸 → 不一定 CO_2 升高。
5. WBC 升高就确定病原 → 病原诊断靠培养/涂片等。
6. 中性粒细胞高就一定细菌 → 应激、炎症也可影响。
7. Hb 低就只写贫血 → 还要判断贫血类型。
8. 缺铁性贫血漏写 MCV/MCH/MCHC → 小细胞低色素是关键。
9. 缺铁只背血清铁低 → 铁蛋白低、TIBC 变化也常考。
10. 溶血性黄疸写尿胆红素阳性 → 溶血多为尿胆红素阴性。
11. 溶血漏写 Ret 升高 → Ret 是骨髓代偿线索。
12. Coombs 阳性忘记自身免疫性溶血 → 这是核心证据。
13. 全血细胞减少就判白血病 → 再障也可全血细胞减少。
14. 再障漏写 Ret 低和骨髓低增生 → 容易丢分。
15. 出血点就只想到血小板 → 凝血因子异常也要用 PT/APTT 鉴别。
16. DIC 只看 D-D → 还要看 PLT、PT/APTT、FIB。
17. PT 延长和 APTT 延长混淆 → PT 外源，APTT 内源。
18. 肝细胞性黄疸只看胆红素 → ALT/AST 很重要。
19. 梗阻性黄疸漏写 ALP/GGT → 胆汁淤积标志。
20. 尿胆红素阳性误判溶血 → 尿胆红素阳性提示结合胆红素。
21. AFP 升高就确诊肝癌 → 需结合乙肝/肝硬化、影像和病理。
22. CEA 升高就确诊结肠癌 → 肿瘤标志物只是辅助。
23. 便潜血阳性只想到胃癌 → 溃疡、结肠癌等都可阳性。
24. 尿蛋白阳性就一定肾炎 → 需结合血尿、管型、肾功能。
25. 血尿就一定肾小球病 → 结石、肿瘤、外伤也可血尿。
26. 感染后血尿漏写 ASO/C3 → 急性肾炎高频点。
27. 尿路感染不写尿培养 → 病原学和药敏是关键。
28. BUN/Cr 升高只写肾衰 → 还要结合尿量、病因和电解质。
29. 脑膜炎不写脑脊液糖和氯化物 → 鉴别化脑/结脑会丢分。
30. 化脑和结脑都写淋巴细胞为主 → 化脑常中性粒细胞为主。
31. 病脑误写糖明显降低 → 病毒性脑膜炎糖多正常。

32. 胸水 ADA 高就判恶性 → ADA 高更支持结核或脓胸。
33. 脓胸只写 WBC 高 → pH 低、中性粒为主也要写。
34. 恶性胸水只写血性 → 细胞学或活检才关键。
35. 乙肝表面抗体阳性误认为感染 → 抗-HBs 是保护性抗体。
36. HBsAg 阳性漏写现症感染 → 表面抗原提示感染状态。
37. HBeAg 阳性漏写复制活跃 → 常提示传染性较强。
38. 甲亢只看 T3/T4 → TSH 被抑制是高频点。
39. 心梗最早指标误选肌钙蛋白 → 肌红蛋白更早，肌钙蛋白更特异。
40. 心肌标志物阳性就脱离临床诊断心梗 → 要结合胸痛和心电图。

血气：pH 定酸碱，PaCO₂ 定呼吸，HCO₃⁻ 定代谢。
 DIC：PLT↓ + PT/APTT 延长 + FIB↓ + FDP/D-D↑。
 缺铁：Hb↓ + MCV/MCH/MCHC↓ + 血清铁/铁蛋白 ↓。
 溶血：Hb↓ + Ret↑ + IBIL↑ + 尿胆原 ↑ + 尿胆红素阴性。
 梗阻黄疸：DBIL↑ + ALP/GGT↑ + 尿胆红素阳性。
 肾炎：血尿 + 蛋白尿 + 管型 + C3↓/ASO↑。
 化脑：CSF 中性粒多 + 糖 ↓ + 蛋白 ↑。
 结脑：CSF 糖 ↓ + 氯 ↓ + 蛋白 ↑ + 淋巴为主。
 结核胸水：ADA↑ + 淋巴细胞为主。
 脓胸：胸水 WBC 高 + 中性粒为主 + pH↓。
 乙肝：HBsAg 感染，抗-HBs 保护，HBeAg 复制。
 甲亢：T3/T4↑ + TSH↓。
 心梗：肌红早，肌钙准，CK-MB 看动态。
 肝癌：AFP + 乙肝/肝硬化 + 肝占位。

1.6 最后 15 分钟背诵页

1.7 Part 5: 加厚版系统速记 这一部分用于把背诵量从 2 小时扩到 4 小时左右。读法：先看“题干抓手”，再背“检验抓手”，最后遮住判断自测。

5.1 血液一般检查

项目	看到什么	先想到什么	选择题陷阱
RBC/Hb 增高	脱水、慢性缺氧、高原、真红	相对性或绝对性红细胞增多	脱水是血液浓缩，不是真性增多
RBC/Hb 降低	乏力、苍白、心悸	贫血	贫血只是结果，还要分型
MCV↓、MCH↓、MCHC↓	小细胞低色素	缺铁性贫血、地中海贫血、慢性病贫血	缺铁要有铁代谢证据
MCV↑	大细胞贫血	巨幼细胞性贫血	查叶酸、Vit B12
Ret↑	骨髓代偿强	溶血、急性失血恢复期	再障 Ret 常低
Ret↓	造血反应差	再障、骨髓抑制	不能只看 Hb
WBC↑ + N↑	急性感染、炎症、应激	细菌感染倾向	不是病原确诊
WBC↓	病毒感染、药物、骨髓问题	需结合分类	白细胞低也可严重感染
PLT↓	皮肤黏膜出血	血小板减少性出血	与凝血因子病区分

5.2 贫血四大类型

类型	题干抓手	检验抓手	必背鉴别
缺铁性贫血	月经过多、消化道慢性失血、乏力苍白	Hb↓、MCV↓、MCH↓、MCHC↓、血清铁↓、铁蛋白↓	与慢性病贫血、地中海贫血、铁幼粒细胞贫血鉴别
巨幼细胞性贫血	舌炎、纳差、神经症状可有	MCV↑、叶酸/Vit B12↓、骨髓巨幼变	不要误当缺铁
溶血性贫血	贫血 + 黄疸 + 尿色深 + 脾大	Ret↑、IBIL↑、LDH↑、尿胆原↑、Coombs可阳性	与肝炎黄疸鉴别
再生障碍性贫血	贫血 + 感染 + 出血，肝脾不大	全血细胞减少、Ret↓、骨髓增生低下	与白血病、MDS、巨幼贫鉴别

5.3 凝血与出血

出血表现	更像什么	检验组合
皮肤瘀点、紫癜、鼻出血、牙龈出血	血小板或血管壁问题	PLT、BT、血小板功能
深部肌肉血肿、关节腔出血	凝血因子问题	PT、APTT、凝血因子
全身多部位出血 + 休克/感染/白血病背景	DIC	PLT↓、PT/APTT 延长、FIB↓、FDP/D-D↑
APTT 延长，PT 正常	内源性凝血异常	血友病方向
PT 延长，APTT 可正常	外源性凝血异常	肝病、Vit K、凝血因子 VII
PT/APTT 都延长	共同通路或多因子异常	DIC、严重肝病、抗凝药

5.4 尿液与肾功能

题干/结果	快速判断	易错点
蛋白尿 + 血尿 + 管型	肾小球受累	管型是肾实质线索
尿 WBC↑ + 尿频尿急尿痛	尿路感染	明确病原靠尿培养
发热 + 腰痛 + 肾区叩痛 + 脓尿	急性肾盂肾炎	与膀胱炎区分：膀胱炎全身症状轻
上感后 1-3 周 + 血尿水肿高血压	急性肾小球肾炎	C3↓、ASO↑ 支持链球菌后
上感后 1-3 天即血尿	IgA 肾病	时间差是题眼
大量蛋白尿 + 低白蛋白 + 水肿 + 高脂血症	肾病综合征	不等于慢性肾炎
Cr 重度升高 + 少尿/无尿	急进性肾炎或急肾衰	需要肾活检/病因判断

5.5 肝功能和黄疸

组合	判断	一句话
ALT/AST 明显升高	肝细胞损伤	转氨酶看肝细胞
ALP/GGT 明显升高	胆汁淤积/胆道梗阻	胆管问题看 ALP/GGT
DBIL 升高 + 尿胆红素阳性	结合胆红素升高	尿里有胆红素，多是结合型

组合	判断	一句话
IBIL 升高 + 尿胆红素阴性 + 尿胆原 ↑	溶血性黄疸	红细胞破坏多，尿胆红素反而常阴性
白蛋白降低、PT 延长	肝合成功能下降	肝功能不只看酶
AFP↑ + 乙肝/肝硬化 + 肝占位	原发性肝癌支持	AFP 不能单独确诊

5.6 脑脊液鉴别

类型	压力/外观	细胞	蛋白	糖/氯	关键词
化脓性脑膜炎	压力↑，可浑浊	中性粒为主 ↑↑	↑	糖↓，氯可↓	高热、脓毒、起病急
结核性脑膜炎	压力↑，可毛玻璃样	淋巴为主↑	↑↑	糖↓、氯↓明显	低热盗汗、病程较慢
病毒性脑膜炎	压力可↑，多清亮	淋巴为主↑	轻中度↑	糖多正常	病情相对轻，糖常正常

5.7 浆膜腔积液

类型	外观	细胞	生化	最关键点
漏出液	多清亮	细胞少	蛋白低、LDH 低	心衰、肝硬化、低蛋白
结核性胸水	草黄色，可血性	淋巴为主	ADA>45，蛋白高	低热盗汗消瘦
脓胸	脓性	WBC 很高，中性粒为主	pH<7.30，糖低，LDH 高	高热、胸痛、感染
恶性胸水	血性多见	可见肿瘤细胞	ADA 常低，CEA 可高	中老年、消瘦、细胞学/活检

5.8 乙肝两对半

指标	阳性意义	速记
HBsAg	现症乙肝感染标志	表抗原 = 感染
抗-HBs	保护性抗体	表抗体 = 保护
HBeAg	病毒复制活跃、传染性强	e 抗原 = 复制
抗-HBe	复制降低或恢复倾向	需结合 HBV DNA
抗-HBc	既往或现症感染痕迹	核心抗体不是保护抗体

5.9 甲状腺功能

结果组合	判断	易错点
T3/T4/FT3/FT4↑ + TSH↓	原发性甲亢	TSH 是负反馈降低
T3/T4↓ + TSH↑	原发性甲减	下丘脑/垂体问题另判
甲亢症状 + 甲状腺弥漫肿大 + 突眼	Graves 病倾向	还需抗体/摄碘等支持

结果组合	判断	易错点
甲亢 + 心悸房颤	甲亢性心脏病可能	老年甲亢可不典型

5.10 心肌标志物

指标	特点	选择题问法
肌红蛋白	升高最早，特异性差	早期最先异常
cTnT/cTnI	特异性高，持续时间长	最有价值/最特异
CK-MB	有动态变化，回落较快	再梗死、溶栓再通峰值提前
BNP/NT-proBNP	心衰辅助	资料未覆盖数值时不硬背

1.8 Part 6: A2 自测清单 遮住右侧答案，用左侧题干组合自测。

题干组合	判断
慢性咳嗽 20 年 + 吸烟 + 桶状胸 + FEV1/FVC<0.70	COPD
慢性咳嗽 + 大量脓痰 + 反复咯血 + HRCT 支气管扩张	支气管扩张
花粉接触后喘息 + 双肺哮鸣音	支气管哮喘
受凉后寒战高热 + 铁锈色痰	肺炎链球菌肺炎
老年人 + 红棕色胶冻样痰	克雷伯杆菌肺炎
糖尿病 + 高热脓血痰 + 多发空洞	金葡菌肺炎
酗酒后 + 大量臭脓痰 + 液平	吸入性肺脓肿
低热盗汗消瘦 + 上肺病灶	肺结核
突发胸痛呼吸困难 + P2 亢进 + PaO2↓PaCO2↓	肺栓塞
急性胰腺炎后呼吸困难 + PaO2↓PaCO2↓pH↑	ARDS
PaO2<60, PaCO2>50	II 型呼衰
胸水 ADA>45 + 淋巴为主 + 低热盗汗	结核性胸水
胸水 WBC 极高 + 中性粒为主 + pH 低	脓胸
血性胸水 + ADA 低 + CEA 高	恶性胸水
持续胸痛 + 硝酸甘油无效 + cTn↑	急性心肌梗死
心梗后心尖区新出现收缩期杂音	乳头肌功能不全/断裂
急性心梗史 + ST 段持续抬高 + 心界扩大	心室壁瘤
心梗后发热胸痛 + 心包摩擦音	心梗后综合征
呕血黑便 + 肝硬化体征 + 脾大腹水	食管胃底静脉曲张破裂出血
乙肝史 + 肝区痛 + AFP 高 + 肝占位	原发性肝癌
上感后 1-3 周 + 血尿水肿高血压 + C3↓ASO↑	急性肾小球肾炎
上感后 1-3 天 + 肉眼血尿	IgA 肾病
少尿无尿 + Cr 重度升高 + 急性肾炎表现	急进性肾小球肾炎
大量蛋白尿 + 低白蛋白 + 水肿 + 高脂血症	肾病综合征
Hb↓ + MCV↓ + 血清铁低	缺铁性贫血
Hb↓ + Ret↑ + IBIL↑ + Coombs 阳性	自身免疫性溶血性贫血
全血细胞减少 + Ret 低 + 骨髓低增生	再生障碍性贫血
贫血发热出血 + 骨髓原始细胞增多	急性白血病
出血 + PT/APTT 延长 + FIB↓ + D-D↑	DIC
黄疸 + ALT/AST 明显升高	肝细胞性损伤
黄疸 + DBIL↑ + ALP/GGT↑	梗阻/胆汁淤积
黄疸 + IBIL↑ + 尿胆红素阴性	溶血性黄疸
高热头痛喷射呕吐 + CSF 中性粒多糖低	化脓性脑膜炎

题干组合	判断
低热盗汗 + CSF 糖氯低蛋白高淋巴多	结核性脑膜炎
T3/T4↑ + TSH↓	甲亢
HBsAg 阳性	乙肝现症感染
抗-HBs 阳性	保护性抗体
HBeAg 阳性	复制活跃、传染性强